

שלב C

אין לשכוח את כלי הדם הגדולים העוברים בצוואר; פגיעה בהם תגרום לשטפי דם פורצים וגדולים. חשוב לקחת בחשבון ששטף הדם יכול להיות גם פנימי, וייתכן שהדם אינו פורץ החוצה, אלא זורם אל קנה הנשימה או יוצר המטומה שגורמת לניפוח אזור הקנה. בשני המקרים התוצאה היא חנק. יש לזכור: לא רק דימום מסיבי מעורק או מווריד גדול יכול לסכן חיים, גם דימום מכלי דם קטנים רבים, שנמצאים באזור הפנים, עלול לסכן את הנפגע עקב איבוד נפח דם גדול, במיוחד אם הנפגע הוא ילד קטן או תינוק.

הטיפול בפגיעות בפנים ובצוואר

- (1) ראשית - שמירה על נתיב האוויר פתוח ובכל מחיר. אם צריך, אינטובציה בהקדם.
- (2) מעקב ואבחנת נשימה אפקטיבית של הנפגע. הנשמה לפי הצורך.
- (3) לאחר שדרכי האוויר אובטחו, עוצרים דימום נראה על ידי לחץ ישיר.
- (4) עושים סקשן לעיתים תכופות אם יש דימום ללוע.
- (5) אם יש התנפחות מקומית, ניתן לנסות לקרר את המקום כדי למנוע הגדלה של הנפיחות.
- (6) בכל פגיעה בפנים יש חשד לפגיעת ראש ועמוד שדרה, ולכן יש לקבע את הצוואר והגב.
- (7) פינוי לבית חולים לפי המצב הכללי של הנפגע.

פגיעות בבית החזה

יש פגיעות אפשריות רבות בבית החזה, למשל פגיעת חזה פתוחה או סגורה, חזה אוויר בלחץ, חזה דם; חלק מהפגיעות הן ישירות כמו פצע חדירה, חבלה קלה, חבלת מעיכה, וחלקן עקיפות, למשל פגיעת הדף. חלקן נראות לעין ואחרות פנימיות ולא נראות.

המנגנון הפתופיזיולוגי של פגיעות בבית החזה

תרחיש הפגיעה (קינמטיקה) נותן מידע חשוב ביותר לצוות המטפל. קבלת מידע מדויק בשלב מוקדם לא רק יחסוך זמן יקר לטיפול המשך, אלא יכוון את חשיבת הצוות המטפל לגבי סוג הפציעה, איברים אנטומיים שנפגעו וכדומה. נהוג לחלק את הפגיעות בבית החזה לשני סוגים עיקריים: פגיעה ישירה (פגיעת חדירה, פגיעה קלה, מעיכה) ופגיעה עקיפה (הדף, האצה/האטה שגורמות לטלטול איברים).

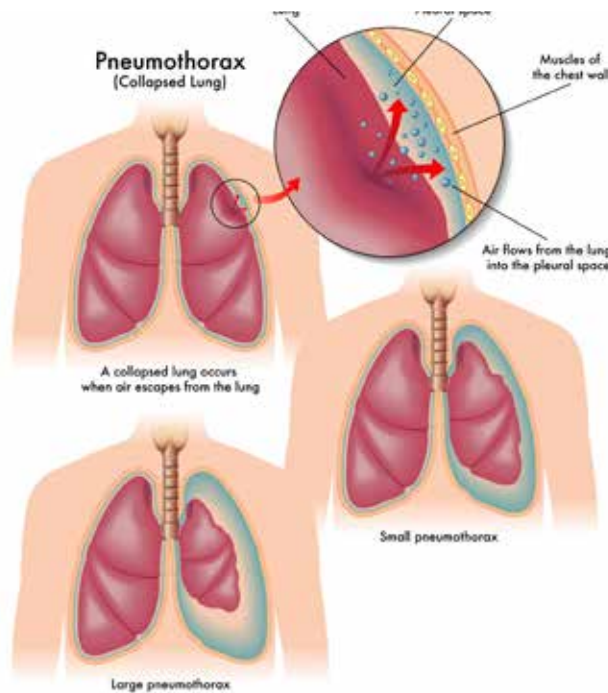
ייתכנו פגיעות במערכת הנשימה ללא פציעות חיצוניות בולטות לעין. יתרה מזאת, ייתכנו מצבים שבהם פציעות בולטות לעין יעכבו טיפול באזורים שבהם פציעה חיצונית אינה ניכרת אך יש פגיעה פנימית חמורה יותר. על כן, האבחנה צריכה להתבסס על הערכת מצב ועל שלילה של פגיעות פנימיות, ולא רק על ידי טיפול ישיר בפציעה הנראית לעין שעושה רושם ראשוני כמסוכנת ובולטת יותר. טוב יעשה המטפל, אם יכלול בהערכתו הראשונית את כל הפציעות האפשריות על פי סיפור המקרה, ורק אחר כך יחפש את הפגיעות המשוערות ויקבע אם אפשר לשלול אותן.

סיפור של קינמטיקה ייחודית כגון: שימוש בנשק בעל מהירות גבוהה או נמוכה או פגיעת מעיכה מאפשר לאבחן פגיעות חזה ופגיעות אפשריות אחרות. מטפל שחושה שהייתה פגיעה ישירה בבית החזה צריך לכלול בהערכתו

173

חזה אוויר בלחץ (Tension Pneumothorax)

חזה אוויר בלחץ זו פגיעה הנגרמת בדרך כלל כפציעה משנית לפגיעות ישירות בריאה או בדרכי האוויר. בעקבות הפגיעה הישירה נכנס אוויר לחלל הפלאורלי. אוויר מצליח לחדור אל בין קרומי הפלאורה, אך אינו מצליח לצאת בעיקר בגלל שנוצר שסתום חד-כיווני של הרקמה. כשאוויר נשאב לחלל הפלאורלי אך אינו יכול להיחלץ החוצה, האוויר נכלא בתוך החלל הפלאורלי והוא דוחק את הריאה בצד הפגוע. כך נוצר תמט של הריאה ומכאן נוצרת היפוקסיה קשה. דחיקת המדיאסטינום לכיוון הצד הבריא, מחמירה את ההיפוקסיה, האוורור הולך ויורד. כמו כן, הניקוז הוורידים מהריאות נפגע גם הוא בגלל הלחץ הגבוה באזור. במקרים קשים יותר פגיעה זו בניקוז הוורידים מהוורידים הנבובים תפגע בתפוקת הלב, עלולה לגרום לקריסה, לא רק של מערכת הנשימה, אלא גם של המערכת הקרדיוסקולרית. למעשה, קריסת המערכת הקרדיוסקולרית היא גורם המוות העיקרי מפגיעה זו.



איור 5.3 חזה אוויר בלחץ

פגיעה בריאה המובילה לחזה אוויר בלחץ (tension pneumothorax). הפגיעה יכולה להיות גם בדרכי האוויר.

פגיעה זו מסכנת חיים אם אינה מאובחנת כבר בשלב הטיפול הראשוני. אפשר לאבחן את המצב על ידי זיהוי מצוקה נשימתית קיצונית, סטיית קנה הנשימה לכיוון הצד הבריא (שאותה קל לראות אצל אנשים רזים), בהאזנה נשמעים הבדלים בכניסת אוויר, רואים גודש בוורידים הצוואריים ואף סימני הלהם. נגרם בשל ירידה בחזרת הדם ללב ועקב כך יורדת תפוקת הלב. יש לנקז מייד את האוויר הלכוד בבית החזה.

הפרוצדורה ניקוז חזה במחט (needle application: NA) נעשית על ידי הכנסת מחט (needle application) - למרווח הבין-צלעי השני (בין צלע 2 לצלע 3) בקו האמצע בריחי (midclavicular line). זהו ניתוח זעיר פולשני. פרוצדורה זו תגרום לשחרור הלחץ המוגבר בבית החזה, לשיפור של תפקוד הלב ולהקלה זמנית במצבו של הנפגע. לאחר הניקוז יש לשקול התקנת נקז חזה קבוע - טרוקר (trocar chest tube). השיקולים יהיו לפי מצב הנפגע, מרחק פינוי וסמכויות רפואיות (הרחבה בפרק 25).

חזה דם (Hemothorax)

פגיעה זו היא בדרך כלל פגיעה משנית. היא נלווית לפגיעות אחרות בבית החזה שגורמות לדימום מסיבי מכלי דם בין־צלעיים או כלי דם אחרים באזור בית החזה. חזה דם חמור יופיע בדרך כלל לאחר פגיעות חזה ישירות וחודרות. הדימום המסיבי תופס את מקומה של הריאה ומוביל לתמט שלה. הימצאות של דם רב בחלל בית החזה תוביל לחוסר יכולת אוורור של הריאה ומכאן להיפוקסיה.

פגיעה חודרת באזור שבין הפטמות תרמוז על פגיעה אפשרית בלב (אפשרות לטמפונדה לבבית, פגיעה בכלי הדם הגדולים ובמבנים אחרים: קנה הנשימה, וסט, קיבה. במבוגר, ההגדרה של חזה דם היא איבוד 1,500 סמ"ק דם אל חלל בית החזה או למערכת הניקוז (למשל אם הותקן טרוקר). במקרה זה יופיעו סימנים של הלם הפיזיולוגי (תת־נפחי) ובבדיקה יישמעו קולות עמומים בניקוש בית החזה וכן היעדר קולות נשימה בצד הפגוע. כמו כן, ייתכן תמט של ורידי הצוואר בשל ההיפוקסיה או גודש בוורידי הצוואר עקב חזה אווריר בלחץ. נוסף על אלה, עלולה להיווצר גם טמפונדה לבבית (cardiac tamponade).

השפעת הפגיעה על מעבר הגזים בריאה

נפגעים עם פגיעה בריאות עלולים לסבול מירידה בשחלוף התקין של הגזים בריאה. הפגיעה בשחלוף נגרמת בגלל חוסר התאמה בין האוורור הריאתי ובין זרימת הדם לריאות. נוסף על כך, פגיעה פיזית של הריאה, כמו חבורה (קונטוזיה) ריאתית (pulmonary contusion), פוגעת ביכולת הפיזית של אותה ריאה לממש את שחלוף הגזים דרכה.

חבורה (קונטוזיה) ריאתית היא אחד הגורמים העיקריים לתמותה מפגיעות חזה, לא רק בגלל הסיבות המצוינות לעיל. מחקרים הראו שהחבורה הריאתית היא דינמית - הדימום ברקמת הריאה נמשך, ועם הזמן נוצרות באזור בצקות קשות שמקשות עוד יותר על מעבר הגזים. אי־ספיקה נשימתית עקב חבלה ריאתית, תזוזת מבנה בית החזה בשל המכה וחזה אווריר או חזה דם - כל אלה יכולים לגרום לפגיעה קשה ובלתי הפיכה גם בריאה הבריאה. חוסר התאמה של האוורור והפרפוזיה של הריאות יכול לגרום לשאנט (shunt) בסדר גודל של עד 30%. ההיפוקסיה תחל כ־10 דקות לאחר הפציעה. מאוחר יותר, ההיפוקסיה המתקדמת תקטין את חוסר ההתאמה של הגזים והדם לכ־5% בלבד, עקב התכווצות כלי דם מקומיים.

פגיעות בבית החזה שגורמות לפגיעות במערכת הקרדיווסקולרית ולהלם

פגיעות במערכת הנשימה יכולות להוביל למצב של הלם. אפשר לראות פציעות בכלי דם גדולים הנמצאים בבית החזה או הקשורים למערכת הנשימה. הדבר יגרום לירידה ניכרת בתפוקת הלב, ויגרור את איברי הנשימה לאי־ספיקה ולהיפוקסיה; גם הלב עשוי להגיע לאי־ספיקת לב, לאיסכמיה ולאטום (myocardial infarction: MI).

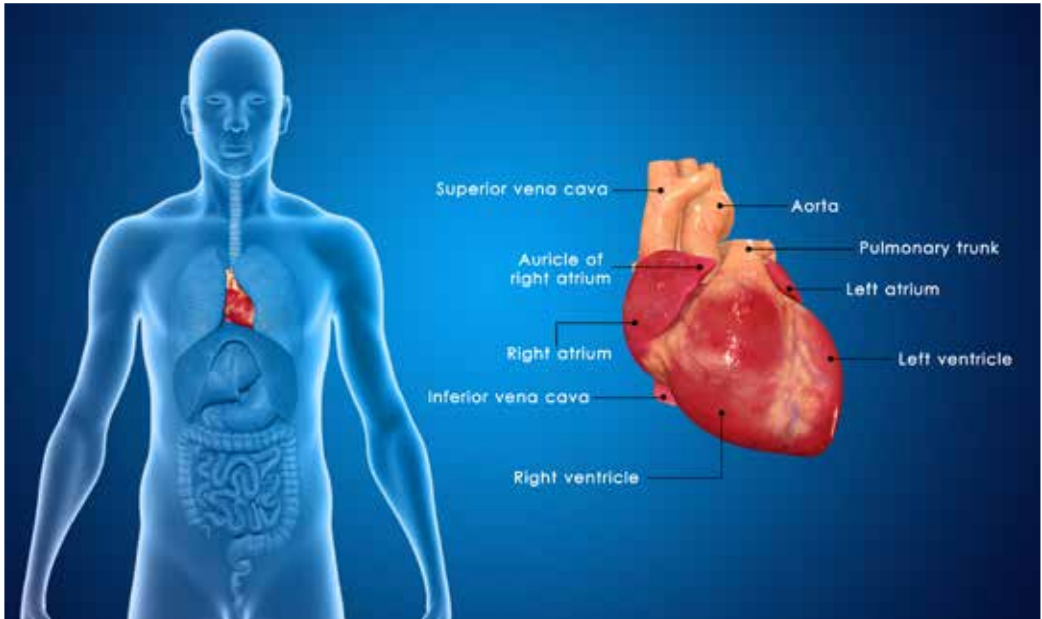
פגיעה בלב

פציעה קלה יכולה לגרום לירידה ביכולת ההתכווצות של הלב ובגמישות כלי הדם, ומכאן לירידה בתפוקת הלב; פגיעה נלווית במערכת הקורונרית או בכלי דם אחרים באזור יכולה לגרום לנקרוזה (הרס תאים בשל תהליך נמקי) של הרקמה ולאטום שריר הלב. כשמדובר בפגיעה של כמה איברים (ולא רק פגיעה בלב) המלווה בהיפוקסיה ובהיפוקסיה, תפוקת הלב תרד עוד יותר בגלל פרפוזיה קורונרית ירודה, שתוביל לאי־ספיקת לב.

חמורה ביותר. כ־20% מנפגעים אלה יסבלו גם מהפרעות בקצב הלב - הפרעת קצב עלייתית או הפרעת קצב חדרית, והפרעות הולכה. אוטם שריר הלב יכול להוביל להלם קרדיוגני ולקריסת המערכת הקרדיווסקולרית. פגיעה טראומטית במסתמי הלב יכולה לגרום להגדלת נפח חדרי הלב ומכאן למערבולות בזרימת הדם אם חלק מהדם יזרום בכיוון ההפוך לכיוון זרימת הדם התקינה. עומס זה על חדרי הלב והזרימה המוגברת של דם בכיוונים שונים יכולים להיות נסתרים מן העין בגלל פציעות דינמיות אחרות. יהיה צורך במכשור ultrasound doppler כדי לאבחן פגיעה במסתמי הלב.

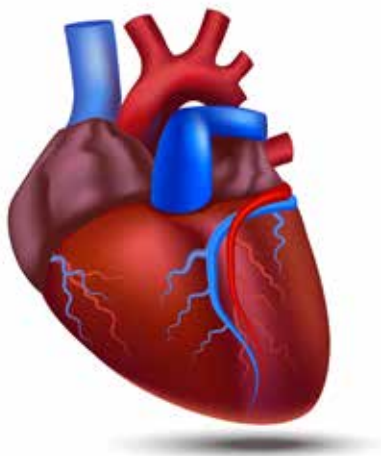
חבורה לבבית (Cardiac Contusion)

זו אחת הפגיעות הקשות ביותר לאבחון. פגיעה זו קורית כשיש דחיסה ישירה של רקמת הלב או האטה פתאומית בתנועה. בדרך כלל פגיעה בבית החזה מלווה בשברים של הסטרנום וברוב המקרים האלה החדר הימני נפגע. בדרך כלל הכאבים בחזה משויכים לחבורה בבית החזה ולשברים בצלעות. האבחון נעשה באמצעות מנגנון הפגיעה, רמת האנזימים הקרדיאליים בבדיקות מעבדה (biomarkers) ושינויים בתרשים אק"ג. אפשר לראות הפרעות קצב מכל הסוגים וכן הפרעות הולכה. האזור הפגוע מגיב כפי שמגיב אזור בלב שעובר אוטם, ומטפלים בנפגע זה על פי הפרוטוקול, כולל קיצוב חיצוני אם נדרש. הסיבוכים של חבורה לבבית יהיו כמו אלה של אוטם חד בשריר הלב. הלם קרדיוגני נדיר במקרה זה, אך יש סיכון לכך. בדרך כלל תידרש התערבות כירורגית דחופה בבית חולים לאיחוי קרעים שנצרו בדופן הלב.



איור 5.4 מנח הלב בבית החזה

בתמונה רואים את הדימום לתוך שק הפריקורד. הנוזל שהצטבר בין קרומי הלב יפעיל לחץ על שריר הלב ויפגע ביכולת ההרפיה שלו.



טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)

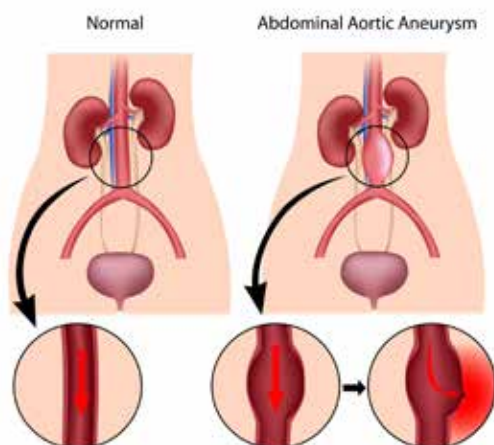
טמפונדה לבבית תיגרם בדרך כלל מפציעות חודרות, אך תיתכן גם מפציעות קהות. הפריקרד (כפורת, קרום הלב, pericardium), עשוי מרקמה פיברוטית חזקה העוטפת את הלב. דימום לתוך שק הפריקרד ימנע הרפיה מלאה של הלב ובשל כך ייפגע מילוי הלב ותיפגע יכולתו לפעול כראוי. בפגיעה זו תהיה ירידה בתפוקת הלב. אפשר לראות את הסימנים על שם בק (Beck's triad) - עלייה בלחץ הווריד המרכזי (גודש ורידי צוואר), לחץ דם נמוך וקולות לב עמומים.

איור 5.5 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)

בתמונה רואים את הדימום לתוך שק הפריקרד. הנוזל שהצטבר בין קרום הלב יפעיל לחץ על שריר הלב ויפגע ביכולת ההרפיה שלו.

קרע (דיסקציה) של אבי העורקים

קרע של אבי העורקים הוא פגיעה קטלנית מיידית אצל 90% מהנפגעים. בדרך כלל קרע זה נגרם ממכה קלה או מהאטה פתאומית בתנועה, במיוחד לאחר תאונות דרכים או נפילות מגובה. הקרע יכול להיות מלא או חלקי. אבי העורקים מקובע בשלוש נקודות - במסתם האאורטלי*, בחיבורי הגידים ובגיד הסרעפת. האטה פתאומית תגרום לחלקים שאינם מקובעים להמשיך לנוע יחסית לחלקים המקובעים, והם עלולים להיקרע ולהתנתק מחיבורם. ההישרדות מפציעה כזו תלויה בדרך כלל בהיווצרות מפרצת שבה השכבה החיצונית נשארת שלמה והדימום נכלא בין השכבות של דופן אבי העורקים. כל חשד לקרע של אבי העורקים מצריך בדיקה יסודית בבית חולים, במיוחד כאשר בבדיקה מתגלה שעוצמת הדפקים אינה זהה בין הגפיים או כשרואים נפיחות בטנית. בזמן העברת הנפגע לבית חולים יש לשמור על מינימום של טלטול ולהקפיד על הנשמה מלאכותית במידת הצורך. יש לשמור על לחץ הדם הסיסטולי 90 מ"מ ולא לאפשר עלייה מעבר לכך כדי למנוע הרחבת הקרע ופריצתו או יצירת קרע נוסף באזור.



איור 5.6 דיסקציה (קרע) של אבי העורקים הבטני (Abdominal Aorta)

משמאל: אבי העורקים התקין, באמצע: אבי העורקים עם מפרצת ומימין: השלב הסופי - קרע (דיסקציה).

* מסתם הוא חלק מן האיבר, שסתום הוא חיצוני.

שברים בצלעות

אפשר למצוא שברים בצלעות ביותר מ-50% מפגיעות החזה הקלות. סטטיסטית בדרך כלל נשברות צלעות 4 עד 9 משום שהן פחות מוגנות על ידי איברים אחרים, והן מקובעות היטב בשני הצדדים (עמוד השדרה והסטרנום). נדרש כוח רב לשבור את שלוש הצלעות הראשונות היות שהן מוגנות על ידי הכתפיים, הסקפולות (עצמות השכם) וגוש השרירים של החזה הקדמי. לכן נדרשת אנרגיה רבה כדי לשבור אותן. מכאן שאם צלעות אלה שבורות, בדרך כלל הפגיעה מלווה גם בפגיעה באבי העורקים, בעץ הברונכיאלי ובאיברי חזה אחרים; פגיעה כזו מעלה את שיעור התמותה ל-30%.

צלעות 9 עד 12 פחות מקובעות לסטרנום והן גמישות יותר, ולכן הסיכוי שהן יישברו קטן יחסית. עם זאת עצמות אלה יעבירו את האנרגיה הלאה לאיברים הפנימיים, איברי הבטן: הקיבה, הטחול, הכבד, בלי להישבר, ובכך עלולות לטשטש סימני פגיעה. התמותה בגלל שברים בצלעות מושפעת לא רק ממספר הצלעות השבורות ומיקומן אלא גם מגיל הנפגע וממחלות רקע שלו. עצמותיו של ילד קטן הן עצמות סחוסיות וגמישות, אלה פחות יישברו בטראומה אך יעבירו הלאה את האנרגיה הקינטית, ללא סימני שבר. באדם זקן העצמות שבריריות יותר ויש סיכויים למחלות רקע שונות (כגון COPD), ולכן למטופל יהיו רזרבות נשימה קטנות לפני הפגיעה; אלה ישפיעו על מצב הנשימה שלו. כמו כן, פריכות העצמות אצל הזקן יכולה לגרום לדקירת הריאה על ידי שברי עצמות חדים ולגרום להמופנאומוטורקס.

הנפגע עם שברים בצלעות ירגיש כאבים עזים בכל פעם שינסה לנשום, היות שבתנועת בית החזה בזמן הנשימה יש תזוזה של הצלעות. כדי להימנע מכאב הנפגע ינסה לנשום נשימות שטחיות יותר. בחלוף הזמן הנפגע עלול להיכנס לאי-ספיקה נשימתית עקב הימנעותו מנשימות עמוקות בגלל הכאבים העזים שהוא מרגיש. נאדיות הריאה של הנפגע לא יתמלאו באוויר, ולכן יתמוטטו ולחלופין יתמלאו בדם מהפציעה. כך או כך, נאדיות אלה לא יוכלו לחמץ את הדם. מצבו של הנפגע ילך ויחמיר בהדרגה. מכיוון שהבעיה העיקרית הפוגעת באיכות הנשימה היא הכאב, יש לשקול לתת משככי כאבים לפי המצב.

חזה צנוח, מרפרף (Flail Chest)

חזה צנוח (או מרפרף) הוא מצב ייחודי שבו יש כמה שברים לאורך הצלע, בכמה צלעות מקבילות. הדבר יוצר אזור שלמעשה התנתק מקיר בית החזה, ולכן הוא אינו נע יחד עם התנועיות של בית החזה. מצב זה מסוכן ביותר, ובדרך כלל מלווה בחבורה (קונטוזיה) ריאתית (pulmonary contusion, lung contusion) - החלק המנותק מכויד ולוחץ על הריאה ומונע ממנה להתמלא אוויר.

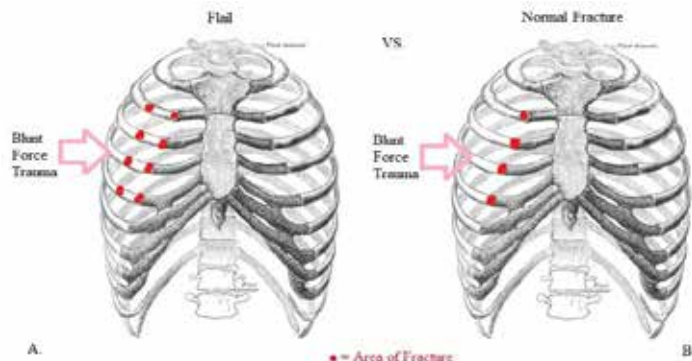
איור 5.7 חזה רופף (Flail Chest)

הנקודות האדומות מסמנות אזור השבר.

מימין: אפשר לראות בכל צלע אזור שבר יחיד, זהו שבר רגיל.

משמאל: אפשר לראות כמה שברים לאורך אותה צלע (שניים בתמונה) ובכמה צלעות מקבילות - אלו שברים הגורמים לחזה רופף (flail chest).

(צילום: (Mrnave, CC BY-SA 3.0)



כשהנפגע מנסה לשאוף אוויר בית החזה עולה, אך החלק שבין השברים נשאר במקומו והוא ייראה שקוע יותר. בעקבות שקיעתו של החלק הפגוע לא מתאפשר מילוי אוויר ובאזור זה של הריאה אין שחלוף גזים. תופעה זו מכונה נשימה פרדוקסלית, היות שנראה כאילו החלק המנותק נע הפוך מתנועת בית החזה, אף שלמעשה החלק המנותק אינו נע. כשהנפגע נושף, קיר בית החזה יורד, אך חלק מנותק זה אינו נע. ככל שהנפגע יתעייף, הנשימה הפרדוקסלית תבלוט יותר, היות שבשלב הראשוני ייתכן שהמבנה השרירי של בית החזה לא יאפשר להבחין בנשימה זו. כמות האנרגיה הנדרשת כדי לגרום לתנועה של חזה רופף (flail chest) היא עצומה. לכן, יש לחשווד שיש פציעות חמורות אצל נפגע זה, כולל פגיעות בעמוד השדרה.



רטון 9. נשימה עם flail chest ונשימה פרדוקסלית

הטיפול (טרומ'אשפוז)

בסקירה הראשונית החשד יתעורר על סמך סיפור המקרה.

הטיפול יהיה בבעיות המסכנות חיים בטווח המיידי. הטיפול על פי ABCDE (עקרונות טיפול SLTHP):

A

- יודא נתיב אוויר פתוח, חיפוש אחר גוף זר, שאיבת הפרשות/דימום.
- אבטוח נתיב אוויר (טראומה - דחיקת לסת).

B

- חשיפת בית חזה וסריקה אחר סימנים (גודש ורידי צוואר, סטיית קנה, אמפיזמות תת עוריות) ופציעות (גם בתי שחי ושכמות אם ניתן).
- בדיקת תנועה סימטרית של בית החזה ושימוש בשרירי עזר.
- האזנה לריאות (בדיקת קולות נשימה המעידים על פגיעות).
- מעקב אחר איכות הנשימה וסדרה - זיהוי מצוקה נשימתית והיפוקסיה.
- חבישת פצעים פתוחים יונקים בחבישת אשרמן.
- NA - אם יש עדות לחזה אוויר בלחץ.
- ניטור מצב הנשימה. אם יש החמרה - מסירים חבישה.
- סיפוק חמצן בריכוז מירבי או מתן הנשמה מסייעת במידת הצורך (ברדיפנאה). חיבור פאלס-אוקסימטר.

C

- בדיקת סימני הלם - דופק, צבע עור, מילוי קפילרי. מעקב לחץ דם.
- חיבור למוניטור ובדיקת הימצאות הפרעות קצב (חשש לפגיעה בלב).

Fight OR Flight

- לשקול טיפול בנוזלים לשמירה על לחץ דם של 90 ממ"מ סיסטולי.
- פינוי בדחפויות לבית החולים לפי מצב הנפגע תוך ניטור מתמיד (רצוי באט"ן).

פגיעות נוספות במערכת הנשימה

פגיעה בדרכי אוויר

נכחות של אוויר חופשי באזור הצוואר (אמפיזמה תת־עורית) או בית החזה מעורר חשד לפגיעה בדרכי הנשימה. קרעים באזור תיבת הקול נדירים מאוד. אלה מאובחנים על פי צרידות, אמפיזמה תת־עורית וקריטציות במישוש (תחושה כמו של ניילון בועות). אינטובציה תהיה הכרחית רק אם יש חשש שנוצרה חסימה מלאה של דרכי האוויר או אם יש מצוקה נשימתית קיצונית. ייתכן שלא יהיה אפשר להבטיח דרכי נשימה פתוחות, ויהיה צורך לבצע קוניוטומיה בשטח. ביצוע קוניוטומיה בשטח יכול לגרום להתפתחות אמפיזמה תת־עורית גדולה המתפשטת במהירות.

פגיעות בקנה בשל פגיעה קלה בדרך כלל אינן בולטות, במיוחד אם הנפגע מחוסר הכרה. לעומתן, פגיעות חודרות לקנה הנשימה בולטות הרבה יותר ודורשות התערבות כירורגית מיידי. הפגיעה מלווה בדרך כלל בפגיעה במבנה האנטומי של הקנה. בפגיעות ירי ייתכן נזק לרקמות הרכות בגלל אפקט החלל הנוצר מפגיעת הקליע.

במקרים כאלה, קשיים בנשימה וקוצר נשימה יהיו הסימנים הבולטים. יש לזכור שבעת הניסיון לבצע אינטובציה יש לצפות לפגיעה במבנה האנטומי של קנה הנשימה, דבר שיקשה להחדיר את הטובוס.

פגיעה בוושט

פגיעה בוושט בדרך כלל נגרמת מפגיעות חודרות. פגיעות קהות לוושט הן נדירות מאוד, אלא אם כן מכה פתאומית בבטן גרמה לעלייה פתאומית בלחץ התוך־בטני ולקרע של הוושט בגלל עלייה פתאומית של תוכן קיבה ואוויר. הטיפול יהיה בחדר ניתוח, ולא בשטח.

קרע סרעפתי

פגיעות חודרות יכולות לגרום לקרעים באזור הסרעפת. פגיעות אלו בדרך כלל הן ללא השלכות מיידי. מנגד, טראומה קלה יכולה לגרום לקרעים נרחבים של הסרעפת ולהיווצרות בקע בטני (מעבר של איברי הבטן לחלל בית החזה). משום שחלקה הימני של הסרעפת מוגן יחסית על ידי הכבד, הצד השמאלי נפגע בתדירות גבוהה יותר. הטיפול יהיה בבית חולים, בחדר הניתוח, לתיקון הקרעים.